ORIGEM DO DOCUMENTO:			
Gerência do Serviço de Urgência e Emergência – FCECON			
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco na Unidade de Pronto Socorro no Serviço de Urgência e Emergência			PRT.GU.002
DATA 1ª VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
16/12/2025	16/12/2025	01	16/12/2027

1. OBJETIVOS

1.1 Identificar a prioridade do atendimento em função do potencial de gravidade ou de agravamento da queixa apresentada.

1.2 Fortalecer a humanização no acolhimento, organizar e garantir o atendimento rápido e pertinente dos usuários que procuram as Unidades de Pronto Atendimento.

1.3 Monitorar as ações do protocolo e da equipe multidisciplinar.

1.4 Realizar escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência da FCECON.

1.5 Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços de urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento médico imediato.

1.6 Atualizar os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando todos os serviços da rede de assistência à saúde.

1.7 Funcionar como instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo um sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência.

2. ABRANGÊNCIA

Este protocolo se aplica a todos os usuários oncológicos cadastrados na FCECON que procuram atendimento espontâneo ou regulado, adultos e pediátricos, que necessitem de avaliação inicial de risco, em todos os turnos e escalas (24h), incluindo finais de semana e feriados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

O serviço de urgência e emergência representam uma parcela importante na porta de entrada aos atendimentos da Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas, pois grande parte da população busca essa unidade para resolução de problemas relacionado às intercorrências do câncer ou dos tratamentos, ocasionando superlotação nesse serviço, sendo esta uma realidade tanto no cenário internacional quanto no Brasil (O´DWYER, MATTA, PEPE, 2008).

As unidades de pronto atendimento 24h, segundo o Ministério da Saúde, “são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e a rede hospitalar, devendo funcionar 24h por dia, todos os dias da semana, e compor uma rede organizada de atenção às urgências e emergências, com pactos e fluxos previamente definidos, com o objetivo de garantir o acolhimento aos pacientes, intervir em sua condição clínica e contra referenciá-los para os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), para os serviços da atenção básica ou especializada ou para internação hospitalar, proporcionando a continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população” (BRASIL, 2013). A Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS) destacando a necessidade de se trabalhar dentro de um conceito amplo de saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades de saúde, atuando desde a promoção, prevenção, passando pelo diagnóstico, monitoramento, tratamento e a recuperação (NOVAES, NASCIMENTO, AMARAL, 2016).

A Portaria 2048 de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de atendimento às urgências do acolhimento e da “triagem classificatória de risco”. De acordo com esta Portaria, este processo “deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento” (BRASIL, 2002).

O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização,

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos (BRASIL, 2004).

Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a proposta de Acolhimento com Classificação de Risco nas Unidades de Urgências e Emergências (PNH) com o objetivo de organizar o fluxo e reduzir o tempo de espera dos pacientes com urgência médica (BRASIL, 2004).

3.1 Acolhimento com classificação de risco

O Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação das condições dos usuários que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o seu potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento; o profissional de saúde deverá ouvir as queixas, medos e expectativas do usuário, humanizando o atendimento e oferecendo resolutividade para o problema apresentado (BRASIL,2004).

Mais que uma previsão legal, a classificação de risco é entendida como uma necessidade para melhor organizar o fluxo de pacientes que procuram as portas de entrada de urgência/emergência, garantindo um atendimento resolutivo e humanizado àqueles em situações de sofrimento agudo ou crônico agudizado de qualquer natureza (MAGALHÃES, 1998; SANTOS JÚNIOR, 2004; ROCHA, 2005).

Com a crescente demanda e procura pelos usuários dos serviços de urgência e emergência nas Unidades de Pronto Atendimento, torna-se necessário a reorganização do processo de trabalho destas unidades de forma a atender os diferentes graus de especificidade e resolutividade na assistência realizada aos agravos agudos de forma que, a assistência prestada seja de acordo com diferentes graus de necessidades ou sofrimento (ABBÊS, C.; MASSARO, A. Campinas, 2004)

A Política Nacional de Humanização do SUS ratifica que o acolhimento é um dispositivo de maior relevância ética, estética, política e estruturante, além de ser uma ferramenta para organização do processo de trabalho das equipes de saúde (BRASIL, 2009).

É importante ressaltar que a classificação de risco não pretende dar diagnóstico e sim avaliar a prioridade clínica do paciente oncológico em situação de urgência e que o processo se faz com

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

a identificação de risco, utilizando as cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul como preconizadas pelo Ministério da Saúde, e por meio do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em que são identificados sinais e sintomas, levando em consideração a queixa principal do paciente.

Desta maneira, nas Unidades de Pronto Atendimento existirá uma reorganização de fluxo com base na Classificação de Risco, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e suas práticas de exclusão, efetivando-se o atendimento a todos (BRASIL,2009).

3.2 Missões do acolhimento com classificação de risco

- Organizar os serviços de urgência/emergência na rede de atenção à saúde de forma ideal e ser instrumento para atender os pacientes oncológicos com a máxima qualidade possível;
- Acolher e classificar o risco dos usuários que buscam o serviço em situações de urgência na FCECON.

4. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

- Identificar a prioridade do atendimento em função do potencial de gravidade ou de agravamento da queixa apresentada;
- Fortalecer a humanização no acolhimento, organizar e garantir o atendimento rápido e pertinente dos usuários que procuram as Unidades de Pronto Atendimento;
- Monitorar as ações do protocolo e da equipe multidisciplinar;
- Realizar escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência da FCECON;
- Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços de urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento médico imediato;
- Atualizar os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando todos os serviços da rede de assistência à saúde;

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Funcionar como instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo um sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência.

5. RESULTADOS ESPERADOS

- Com a implementação do Protocolo de Classificação de Risco na Rede Municipal de Atendimento de Urgência e Emergência da FCECON será possível:
- Compreender o conceito de rede e organização de atenção à saúde em urgência e emergência;
- Compreender como se organiza o serviço de urgência e emergência na FCECON;
- Compreender o que é acolhimento com classificação do risco, para pacientes em situação de urgência e emergência;
- Sistematizar o processo de trabalho em equipe.

6. ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE NA ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

6.1. Comuns a todos os profissionais da equipe de saúde

- Participar no planejamento, coordenação e avaliação das ações de saúde prestada;
- Programar, executar e avaliar o processo de trabalho com base em prioridades, objetivos e metas propostas;
- Planejar ações que visem otimizar o tempo de atendimento da população com qualidade;
- Avaliação dos resultados de ação e garantia integral dos direitos humanos.

6.2. Portaria/agente administrativo

- Colaborar para a organização do fluxo dos usuários que procuram a unidade de saúde;
- Recepcionar e disponibilizar as Fichas de Atendimento (FA) Classificação de Risco;
- Realizar identificação do paciente com a pulseira constando nome completo, data de nascimento e registro no Sistema SALUX;

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Encaminhar para o enfermeiro todos os usuários para a realização da Classificação de Risco.

6.3. Enfermeiro

- Confirmar a identificação do paciente na pulseira de identificação;
- Utilizar no mínimo 02 (dois) identificadores para checagem da identificação;
- Realizar a Classificação de Risco;
- Proceder à avaliação de risco conforme estratificação proposta (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul) e direcionar conforme tomada de decisão;
- Reclassificar o paciente (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), conforme tomada de decisão, quando necessário e registrar a nova classificação;
- Carimbar e assinar a FA sempre após a classificação.

6.4. Médico

- Colaborar na coordenação das ações de acolhimento da demanda espontânea;
- Confirmar a identificação do paciente na ficha de atendimento no sistema SALUX e na pulseira de identificação. Utilizar no mínimo 02 (dois) identificadores para checagem da identificação;
- Após primeiro atendimento, se julgar necessário, preferencialmente reclassificar no sistema SALUX;
- Realizar consulta médica de acordo a classificação proposta;
- Liberar prescrição médica com o histórico clínico anexado para a sala de medicação;
- Realizar a reavaliação dos pacientes após medicações, exames e melhora clínica, para definir a conduta médica.

7. OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todos os profissionais da unidade devem compreender e pactuar o processo de trabalho e estarem inseridos nele;

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Todos os pacientes identificados, conforme protocolo, devem ser atendidos dentro do tempo estimado;
- Todas as crianças devem ser pesadas;
- Nos casos de evasão do usuário não classificado conforme protocolo o enfermeiro deverá chamar três vezes, com intervalo de tempo de 10 (dez) minutos entre as chamadas;
- Nos casos de evasão do usuário classificado conforme protocolo e que não aguardou o atendimento médico, o médico deverá chamar três vezes, com intervalo de tempo de 10 (dez) minutos entre as chamadas;
- Os usuários hiper utilizadores (que procuram a unidade por repetidas vezes) deverão ser classificados quantas vezes comparecerem ao serviço;
- Usuários classificados e identificados nas cores segundo Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco que aguardam por atendimento médico, podem ser reclassificados a qualquer momento desde que haja a observação de possíveis alterações em seu quadro clínico;
- Os usuários atendidos no setor verde que necessitarem de reavaliação médica terão a continuidade de seu atendimento no mesmo setor;
- Os casos de baixa complexidade que necessitam de acompanhamento, após o atendimento, deverão ser encaminhados às Unidades Básicas de Saúde de referência;
- Haverá uma fila única dos pacientes para o atendimento médico, organizada pela prioridade da classificação (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

8. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

8.1. Classificação de risco

VERMELHO – Emergência – Prioridade zero

Atendimento imediato na sala de urgência.

Encaminhar imediatamente para sala de urgência e avisar o médico responsável.

Ex: Instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória grave, sepse/neutropenia febril com choque, hemorragia ativa importante, alteração súbita do nível de consciência, etc.

LARANJA – Muito Urgente - Prioridade 1

Atendimento em até 10 minutos.

Encaminhar para atendimento médico, avisar o médico responsável.

Esses pacientes deverão ser atendidos com prioridade em relação aos pacientes classificados como AMARELO.

AMARELO – Urgente - Prioridade 2

Atendimento em até 60 minutos.

Encaminhar para atendimento médico.

Esses pacientes deverão ser atendidos com prioridade em relação aos pacientes classificados como VERDE.

VERDE - Pouco Urgente - Prioridade 3

Atendimento em até 120 minutos.

Encaminhar para atendimento médico nos consultórios.

Ex: Dor leve, sintomas estáveis relacionados ao tumor, efeitos colaterais leves do tratamento, etc.

AZUL - Não Urgente - Prioridade 4

Atendimento em até 240 minutos.

Atendimentos sem sofrimento agudos, casos sociais, sem gravidade.

Procedimentos como: dúvidas, orientações e queixas não agudas, dintomas crônicos sem piora, avaliação de resultados de exames laboratoriais sem alterações dos sinais vitais e sem queixas, renovação de receitas, etc.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

9. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

O atendimento ao paciente oncológico na unidade de urgência e emergência da FCECON requer abordagem diferenciada e humanizada, considerando as particularidades clínicas e emocionais associadas à doença e ao tratamento. Esses pacientes apresentam, com frequência, condições clínicas complexas decorrentes do câncer, da imunossupressão induzida pela quimioterapia e radioterapia, além de possíveis complicações infecciosas e hematológicas.

Durante o acolhimento e a classificação de risco, o enfermeiro deve identificar precocemente sinais de alerta, como febre em pacientes neutropênicos, dor intensa, dispneia, hemorragias, náuseas e vômitos persistentes, mucosite grave, alteração do nível de consciência ou sinais de sepse. Nessas situações, o paciente deve ser priorizado de acordo com a gravidade clínica, respeitando os critérios do protocolo institucional e assegurando o atendimento rápido e eficaz.

A equipe multiprofissional deve adotar medidas de precaução e biossegurança, garantindo ambiente acolhedor e seguro, evitando exposição desnecessária e reduzindo o risco de infecção hospitalar. É fundamental manter uma comunicação clara e empática com o paciente e seus familiares, promovendo o conforto, a escuta ativa e o respeito à dignidade humana.

O processo de cuidado ao paciente oncológico em urgência deve ser pautado na integralidade da assistência, articulando o atendimento emergencial com a continuidade do tratamento oncológico e o acompanhamento nas unidades de referência. Dessa forma, o acolhimento na urgência torna-se parte essencial da linha de cuidado oncológico da FCECON, fortalecendo a segurança do paciente e a qualidade do cuidado prestado.

O paciente oncológico deve receber atendimento prioritário e diferenciado durante o acolhimento com classificação de risco, em razão de sua condição clínica e da possibilidade de complicações agudas decorrentes do câncer ou do tratamento antineoplásico.

O enfermeiro responsável pela classificação deve avaliar de forma criteriosa os seguintes aspectos clínicos e situacionais, determinando o nível de prioridade conforme gravidade:

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

9.1. Emergência – Prioridade Zero (Cor Vermelha)

Atendimento imediato na sala de urgência.

Critérios de inclusão:

- Instabilidade hemodinâmica (PAS < 90 mmHg ou FC > 130 bpm com sinais de choque);
- Insuficiência respiratória grave ou saturação O_2 ≤ 90%;
- **Sepse ou neutropenia febril com instabilidade hemodinâmica**;
- **Hemorragia ativa importante** (digestiva, pulmonar, urinária ou ginecológica, Tumoral);
- **Alteração súbita do nível de consciência** (rebaixamento, convulsão, confusão mental aguda);
- Reação anafilática a quimioterápicos ou transfusões;
- Obstrução de vias aéreas ou edema de glote.

9.2. Muito Urgente – Prioridade 1 (Cor Laranja)

Atendimento em até 10 minutos.

Critérios de inclusão:

- Febre **neutropênica (≥ 38,3°C)** sem sinais de choque;
- **Dor intensa** relacionada a processo tumoral, metástase óssea ou compressão nervosa;
- **Dispneia moderada a grave** sem instabilidade hemodinâmica;
- Reação adversa grave a quimioterapia (náuseas e vômitos incoercíveis, diarreia profusa, mucosite grau III/IV);
- **Sinais de infecção local grave** (celulite, flebite, abscesso, infecção de cateter venoso central);
- **Descompensação metabólica** (hiperglicemia ou hipocalemia grave induzida por terapia).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

9.3. Urgente – Prioridade 2 (Cor Amarela)

Atendimento em até 60 minutos.

Critérios de inclusão:

- Dor **moderada** associada à doença de base ou tratamento;
- **Anemia sintomática** (palidez, fadiga, tontura) sem instabilidade;
- Náuseas, vômitos ou diarreia moderada com sinais leves de desidratação;
- **Infecção de cateter sem sinais sistêmicos**;
- **Suspeita de trombose venosa profunda**;
- **Retenção urinária** ou constipação grave;
- **Efeitos colaterais moderados** de quimioterapia ou radioterapia.

9.4. Pouco Urgente – Prioridade 3 (Cor Verde)

Atendimento em até 120 minutos.

Critérios de inclusão:

- Sintomas leves relacionados ao tratamento (fadiga, inapetência, dor leve, náuseas controladas);
- Lesões cutâneas leves ou pequenas áreas de mucosite grau I–II;
- Avaliação de exames laboratoriais e controle ambulatorial.

9.5. Não Urgente – Prioridade 4 (Cor Azul)

Atendimento em até 240 minutos.

Critérios de inclusão:

- Queixas sem sofrimento agudo e sem alteração de sinais vitais;
- Dúvidas sobre tratamento ou uso de medicação;
- Encaminhamentos administrativos, troca de curativo simples ou controle de rotina sem intercorrência clínica;
- Solicitação de prescrição ou renovação de receita médica.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

9.6. Observações Gerais para o Atendimento Oncológico

- Todo paciente com febre, mesmo isolada, **deve ser considerado potencial portador de neutropenia febril**, até prova laboratorial contrária;
- Em caso de dúvida quanto à classificação, **deve-se adotar a prioridade superior**, garantindo segurança ao paciente;
- O profissional deve registrar de forma detalhada os sinais clínicos e a conduta tomada no sistema SALUX e no prontuário físico;
- A equipe multiprofissional deve assegurar comunicação efetiva com o serviço de oncologia clínica para continuidade do cuidado e acompanhamento pós-atendimento.

10. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

Trata-se da identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, usando um processo de escuta qualificada e tomada de decisão baseada em protocolo e aliada à capacidade de julgamento crítico (SÃO LUIZ, SD).

Durante o acolhimento com classificação de risco, o enfermeiro deverá realizar avaliação clínica direcionada, observando parâmetros fisiológicos, sinais de instabilidade e condições específicas dos pacientes oncológicos. Essa avaliação tem como objetivo identificar precocemente situações de risco e padronizar a triagem, garantindo a segurança do paciente e a priorização adequada do atendimento.

A avaliação deve contemplar:

- **Temperatura corporal (T):** investigar febre (> 38°C) ou hipotermia (< 35°C), considerando que pacientes em tratamento quimioterápico podem apresentar **neutropenia febril**.
- **Frequência cardíaca (FC):** avaliar presença de taquicardia ou bradicardia em relação à linha de base do paciente.
- **Frequência respiratória (FR):** observar sinais de esforço respiratório, taquipneia ou apneia.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- **Pressão arterial (PA):** verificar hipo ou hipertensão, considerando o histórico de comorbidades e uso de medicamentos.
- **Saturação periférica de oxigênio ($SatO_2$):** monitorar saturação < 94%, especialmente em pacientes com doença pulmonar ou metástases torácicas.
- **Nível de consciência:** aplicar a **Escala de Coma de Glasgow (ECG)** ou a **Escala de Alerta (AVPU)**, conforme aplicabilidade.
- **Escala de dor:** mensurar a intensidade da dor utilizando a **Escala Visual Analógica (EVA)** ou similar.
- **Glicemia capilar:** aferir em casos de hipoglicemia suspeita, uso de corticosteroides ou presença de sintomas neurológicos.
- **Avaliação geral:** observar palidez, cianose, desidratação, perfusão periférica e sinais de choque.

Tabela 1: Parâmetros de Sinais Vitais – Adultos

Parâmetro	Normal	Alerta / Alterado	Crítico / Emergência
Temperatura (°C)	36,0 – 37,5	37,6 – 38,4 ou < 35,0	≥ 38,5 ou < 34,0
Frequência Cardíaca (bpm)	60 – 100	101 – 120 ou 50 – 59	> 120 ou < 50
Frequência Respiratória (irpm)	12 – 20	21 – 24	≥ 25 ou < 10
Pressão Arterial Sistólica (mmHg)	100 – 139	90 – 99 ou 140 – 159	< 90 ou ≥ 160
Saturação de O_2 (%)	≥ 95	93 – 94	≤ 92
Escala de Glasgow	15	13 – 14	≤ 12

Fonte: Autoria própria, 2025.

Interpretação dos Critérios:

- **Três ou mais sinais vitais alterados** indicam **prioridade vermelha (emergência)**.
- **Febre ≥ 38,5°C associada à toxemia** é critério único para **classificação vermelha**.
- **Alterações moderadas** isoladas podem ser classificadas como **prioridade laranja ou amarela**, conforme o julgamento clínico.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- **Pacientes estáveis e sem risco imediato** podem ser classificados como **verde ou azul**, seguindo o protocolo institucional.

11. IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

11.1. Sinais vitais alterados

VERMELHO: Apresenta três ou mais sinais vitais alterados. Considerar febre associada à presença de toxemia como critério único para classificação na categoria vermelha.

PAS ≥ 180 ou PAD ≥ 120 mmHg, **com sintomas;**
PAS ≤ 90 mmHg, **com sintomas de fraqueza/palidez;**
FC ≤ 60 bpm sintomático;
FC ≥130 bpm, com ausência de febre FR ≤10 ou ≥ 30 rpm;
Sat O2 ≤ 90%, sem ser DPOC;
Febre TAX ≥ 38,5°C em imunocomprometidos e **com toxemia (sinais de prostração, letargia, apatia, má perfusão periférica (tempo de retorno da circulação superior a 3 segundos), hipo ou hiperventilação, cianose).**

LARANJA: Apresentado alteração de dois sinais vitais.

PAS ≥180 ou PAD ≥ 120 mmHg, **sem sintomas;**
FC ≤ 60 assintomático FR ≤ 21 ou ≥ 29 rpm;
Sat O2 91% ou 94% sem ser DPOC;
Febre TAX ≥ 38,5°C em imunocomprometidos e **sem toxemia.**

AMARELO: Apresentado alteração de um sinal vital.

PAS < 180 ou PAD < 120 mmHg;
FR entre 12 e 20 rpm Sat O2 ≥ 95%;
Febre TAX ≤ 38,5°C em imunocomprometidos e **sem toxemia.**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.2. Traumatismo crânio encefálico – TCE

TCE grave

Alteração do estado de consciência + Escala de Coma de Glasgow ≤ 12 Cefaléia ou dor cervical intensa;

Perda de consciência Otorragia;

Náuseas / vômitos persistentes Crise convulsiva;

Ferimento perfurante/ cortante Idoso em uso de anticoagulante.

Confusão mental + Escala de Coma de Glasgow > 12 Cefaleia moderada (Escore 5-7/10);

Sem perda de consciência, náuseas ou vômitos.

Escala de Coma de Glasgow 13-15;

Cefaleia leve;

Trauma de baixo impacto.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.3. Traumas

TRAUMA GRAVE

Dados vitais alterados;

Dor intensa (Escore 8-10/10);

Relato de perda de consciência;

Fraturas com deformidade ou luxações com comprometimento neuromuscular ou dor intensa;

Ferimentos com sangramento ativo Sinais de Choque Circulatório;

Dor com instabilidade da pelve.

TRAUMA MODERADO

Dados vitais normais;

Dor moderada (Escore 5-7/10);

Sinais/sintomas menos graves em múltiplos sistemas Estado de consciência normal (alerta);

Fratura sem deformidade;

Ferimentos extensos sem sangramento ativo.

TRAUMA LEVE

Dor leve (Escore 1-4/10);

Contusões/entorses e escoriações leves.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.4. Queimaduras

Dados vitais alterados;
Queimaduras de 2°/3° graus ≥ 10%;
Queimaduras de 2°/3° graus em face e períneo;
Queimaduras elétricas;
Queimaduras circunferenciais;
Queimaduras em ambientes confinados.

Dados vitais normais;
Queimaduras de 2°/3° graus < 10% SCQ;
Queimaduras de 1° grau ≥ 10 % SCQ em áreas não críticas;
Queimaduras de 1° grau em face e períneo;
Queimaduras de mãos e pés de qualquer grau.

Queimaduras de 1° grau < 10% SCQ em áreas não críticas.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.5. Intoxicações agudas (exógenas por produtos e venenos)

Alteração de Nível de Consciência;
Relato de ingestão há menos de 6h **com ou sem sintomas;**
Dificuldade respiratória (edema de glote) Dados vitais alterados;
Pupilas puntiformes Crise Convulsiva;
Sinais neurológicos alterados.

Dados vitais normais;
Relato de ingestão há mais de 6h e **sintomático**;
Prurido e/ou irritação intensa em superfície corporal.

Dados vitais normais;
Alterações dérmicas apenas locais;
Contato há mais de 06h e assintomático.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.6. Desconforto respiratório (dispneia/crise asmática)

FR ≥ 30irpm;

Sat. O2 ≤ 90% não portador de DPOC ou doença pulmonar crônica Sat. O2 ≤ 88% portador de DPOC;

Esforço respiratório moderado ou grave;

Estridor laríngeo;

Obstrução de vias aéreas;

Cianose;

Alteração nível consciência.

FR entre 21 e 29irpm;

Esforço respiratório leve;

Sat ≥ 90% a ≤ 94% não portador de DPOC ou doença pulmonar crônica;

Dispneia aos esforços;

Dor torácica ventilatório-dependente com ou sem febre;

Dor de garganta com febre, com placas e com toxemia **(sinais de prostração, letargia, apatia, má perfusão periférica (tempo de retorno da circulação superior a 3 segundos), hipo ou hiperventilação, cianose).**

FR entre 12 e 20irpm Sat O2 ≥95%;

Sat ≥88% portador de DPOC sem desconforto respiratório;

Dor Torácica ao tossir;

Secreção nasal amarelada;

Dor de garganta com febre e com placas sem toxemia;

Tosse, coriza, obstrução nasal crônicas ou recorrentes sem febre e sem toxemia.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.7. Dor torácica

Dados vitais alterados;

Dor no peito de forte intensidade e início súbito e/ou falta de ar e/ou cianose, dor em queimação ou aperto com irradiação para um ou ambos os membros, dor epigástrica, acompanhada freqüentemente de sudorese, náuseas, vômitos ou dispneia (Dor Típica);

História anterior de IAM, angina ou aneurisma Rebaixamento do nível de consciência.

Avaliar e registrar: intensidade da dor, dados vitais, se espontânea ou traumática, duração, característica, localização, irradiação, uso de medicamentos, fatores que pioram ou melhoram.

Cuidado com idosos, diabéticos e paciente com passado de IAM ou embolia pulmonar.

Dados vitais normais;

Dor ventilatório dependente ou que piora com tosse, acompanhada de febre, tosse ou expectoração associado a toxemia (sinais de prostração, letargia, apatia);

Dor moderada.

Dados vitais normais;

Dor de característica muscular (localizada, evidenciada à palpação, que piora com movimentos do tronco ou membros superiores);

Dor aguda leve, sem outros sintomas associados e em pacientes sem história prévia de coronariopatia ou embolia pulmonar.

Dados Vitais normais;

Dor crônica sem característica de DOR ISQUÊMICA (dor atípica).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.8. Queixas abdominais e urinárias

Dados vitais alterados;
Dor abdominal intensa com náuseas vômitos e sudorese Prostração, palidez cutânea;
Dor abdominal alta com suspeita de DOR ISQUÊMICA (ver Dor Torácica);
Dor abdominal intensa pós trauma.

Dados vitais normais;
Dor moderada com distensão abdominal e/ou febre ou relato de febre;
Vômitos e/ou diarreia intensa com sinais de desidratação (vários episódios nas últimas horas);
Retenção urinária aguda com bexigoma;
Dor lombar intensa com sintomas urinários e/ou febre;

Dados vitais normais;
Dor leve;
Enjoo ou relato de vômitos e/ou diarreia sem sinais de desidratação;

Dados vitais normais;
Constipação intestinal sem outros sintomas;
Dor crônica.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.9. Dor cervical, dorsal, lombar ou em extremidade (sem história de trauma)

Dor intensa com alteração dos dados vitais;
Com sinais de isquemia;
Sinais de isquemia aguda: cianose, palidez cutânea, diminuição da temperatura distal, diminuição ou ausência de pulso distal.

Dor moderada com alteração dos dados vitais;
Sem sinais de isquemia;

Dor leve sem alteração dos dados vitais;
Limitação leve dos movimentos sem perda de função.

Dor leve;
Sem limitação dos movimentos ou perda da função;
Sem edema ou sinais flogísticos locais.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.10. Cefaleia

Dados vitais alterados;

Dor intensa;

Alteração do estado de consciência;

Sinais neurológicos focais (paresia, parestesia, disfasia, afasia, disartria, ataxia, alteração de campo visual, distúrbio do equilíbrio);

PAS >180 ou PAD ≥ 120 mmHg.

Dados vitais normais + Dor moderada com náuseas e/ou vômitos.

Dados vitais normais;

Dor leve.

Dados vitais normais;

Dor crônica ou recorrentes sem piora recente.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.11. Alteração aguda do estado neurológico e relato de convulsão, desmaio ou síncope

Dados vitais alterados EC GLASGOW ≤ 13;

Piora de seqüela neurológica prévia;

Em pós- ictal e torporoso/comatoso;

Com crises repetitivas e sem recuperação completa da consciência entre as mesmas;

Com déficit neurológico agudo (paresia, plegia, disfasia, ataxia, paralisia facial);

Rigidez de nuca, hipertonicidade, rigidez muscular;

Distúrbio súbito e inédito do equilíbrio associado a náuseas/vômitos;

Movimentos tônicos - clônicos, agitação motora e sialorreia;

Paciente desmaiado.

Dados vitais normais;

Relato de primeira crise convulsiva em estado pós-ictal alerta;

Crise convulsiva menos de 06 horas com nível de consciência preservada no momento;

Relato de desmaio ou síncope Hemiparestesia (formigamento, dormência);

Vertigem rotatória sem causas conhecidas;

Distúrbios neurovegetativos.

Dados vitais normais;

Crise convulsiva há mais de 06h com nível de consciência preservada no momento;

Vertigem não rotatória;

Parestesias bilaterais ou migratórias.

Dados vitais normais;

História de crise convulsiva/epilepsia e precisando de medicação (receita).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.12. Distúrbios psiquiátricos e abstinência de álcool e drogas

Dados vitais alterados;
Delírios, alucinações, confusão mental, ansiedade intensa, auto e heteroagressão;
Agitação psicomotora intensa;
Tentativa de autoextermínio;
Convulsão, déficit neurológico agudo, letargia.

Dados vitais normais;
Quadro depressivo grave com **ideação suicida;**
Sinais de Abstinência.

Dados vitais normais;
Humor deprimido;
Perda de interesse por atividades.

Dados vitais normais;
Depressão crônica;
Insônia;
História de distúrbio psiquiátrico e precisando de medicação (receita).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.13. Hipertensão

PAS ≥ 180 ou PAD ≥ 120mmHg **com sintomas;**
Alteração do estado de consciência;
Dor torácica sugestiva de isquemia;
Sinais neurológicos focais (paresia, plegia, disfasia, afasia, ataxia, paralisia facial)
Epistaxe franca.

Cuidados com grávidas! Seguir protocolo gestante!

Investigar história pregressa de hipertensão arterial e uso/suspensão de anti-hipertensivos!

PAS ≥ 180 ou PAD ≥ 120mmHg **sem sintomas.**

PAS ≤ 180 e PAD < 120mmHg;
História de hipertensão arterial.

História de hipertensão arterial e precisando de medicação (receita).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

11.14. Diabetes

Glicemia ≤ 60mg/dl ou > 400mg/dl;

Alteração do estado mental (letargia, confusão mental, agitação, irresponsível, visão turva, coma);

Taquipneia + Taquicardia + vômitos + Hálito cetônico;

Sudorese profusa.

Glicemia > 250mg/dl.

Glicemia > 60mg/dl ou < 250mg/dl.

História de diabetes e precisando de medicação (receita).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.15. Sangramentos

(hematêmese/hematoquezia/melena/hemoptise/epistaxe/metrorragia)

Dados vitais alterados (PAS < 90 e/ou PAD < 60 mmHg);
Hematêmese, hematoquezia, melena, hemoptise, epistaxe ou metrorragia intensa;
Epistaxe com PA ≥ 180/120mmHg.

Dados vitais normais;
Hematêmese, hematoquezia, melena, hemoptise, epistaxe ou metrorragia moderada em não grávidas.

Dados vitais normais;
Relato de hematêmese, hematoquezia ou hemoptise leve (raias de sangue);
Relato de melena (normal no momento);
Sangramento vaginal em não grávidas.

Relato de hemorroidas com dor leve e sem sangramento;
Relato de epistaxe (normal no momento).

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

11.16. Queixas oculares

Dor ocular intensa;
Diminuição súbita da acuidade visual;
Trauma ocular grave;
Presença de corpo estranho ou contato com substância química ou solda com dor intensa.

Olho avermelhado com história de trauma leve e dor moderada;
Celulite Periorbitária.

Dor leve;
Prurido ocular;
Hemorragia na esclera sem história de trauma com PA normal.

Olho avermelhado sem história de trauma e sem sinais de infecção;
Terçol ou calázio sem celulite.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.17. Afecções de pele e alergias

Edema olhos/boca;
Dificuldade de falar/respirar.

Prurido generalizado intenso com infecção secundária e sinais sistêmicos;
Placas eritematosas pelo corpo com início súbito;
Grandes abcessos com febre e sinais de toxemia.

Abscesso sem febre;
Pacientes com feridas crônicas ou superficiais com infecção secundária;
Prurido discreto.

Quadro crônico sem sinais sistêmicos.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.18. Diarreia e vômitos

Hipotensão e/ou hipoglicemia **(realizar dextro);**
Vômitos e diarreias persistentes com sinais de desidratação grave;
Dor abdominal de forte intensidade.

Normotenso e normoglicêmico;
Vômitos e diarreias persistentes com sinais de desidratação moderada;
Dor abdominal moderada.

Dados vitais normais;
Vômitos e diarreias persistentes sem sinais de desidratação;
Dor abdominal leve.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.19. Situações ginecológicas e obstétricas

Dados vitais alterados;
Dor intensa ≥ 7-10;
PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg;
Trabalho de parto (TP) em período expulsivo;
Contrações intensas a cada 2 minutos;
Perda de líquido;
Sangramento vaginal intenso ou moderado;
Sangramento vaginal em gestantes;
Pós-parto imediato.

Dor moderada 4-6/10 em gestante;
PAS de 140 -159 e/ou PAD 90-109 mmHg, sem sintomas;
Contrações com intervalos maiores que 3 minutos;
Náuseas e vômitos de início agudo ou persistentes;
Sangramento leve em gestantes;
Sinais e sintomas sugestivos para pielonefrite (febre + dor lombar + disúria);
Lesões vulvares externas;
Relato de ausência de movimentos fetais (MF) em gravidez ≥ 22 semanas
Ingurgitamento mamário;
Gestante e puérpera imunodeprimida;
Dor abdominal em puérpera.

Dados vitais normais;
Dor leve < 3/10;
PAS ≤ 139 e/ou PAD ≤ 89 mmHg.

Menstruação irregular ou atraso.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

11.20. Situações especiais

- Idoso;
- Deficientes mentais;
- Deficientes físicos;
- Acamados;
- Dificuldade de locomoção;
- Gestante;
- Escoltados, algemados, envolvidos em ocorrência policial ou privados de liberdade;
- Profilaxia Pós Exposição;
- Vítimas de violência e abuso sexual;
- Violência Doméstica;
- Paciente perturbador;
- Portadores de necessidades especiais respeitando LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.

Esses pacientes devem ter atenção especial da equipe de acolhimento/classificação de risco e dentro do possível, a sua avaliação deve ser priorizada, respeitando a situação clínica dos outros pacientes que aguardam atendimento.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

12. AVALIAÇÃO DO PACIENTE

- Queixa principal (início, evolução, tempo de início dos sinais e sintomas);
- Medicações em uso, doenças pregressas, alergias e vícios;
- Estado físico do paciente (inspeção e observação);
- Sinais de Alerta: pressão arterial, temperatura, saturação de oxigênio, glicemia capilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, diurese, dor, sangramento agudo, alteração do nível de consciência e dor torácica aguda;
- Aplicação de escalas pertinentes à queixa principal;
- Aplicação dos riscos assistenciais;
- A reclassificação poderá ocorrer toda vez que os sinais ou queixas apresentadas sofrerem alterações ou de acordo com avaliação médica.

13. COLETA DE DADOS

13.1. Coleta de dados direcionada a pacientes com queixas respiratórias

- Principais queixas: Dor torácica (dor no peito), falta de ar, tosse seca ou produtiva, com ou sem presença de sangue (hemoptise).
- Situações de emergências: Ausência de movimento respiratório, sinais de engasgamento por obstrução de vias aéreas por corpo estranho, sinais severos de insuficiência respiratória, trauma penetrante ou contuso em região torácica.
- Sinais de alerta: Atenção especial ao padrão e frequência respiratória, perfusão periférica e tempo de preenchimento capilar.

- Queixa atual: Início dos sinais e sintomas apresentados, fatores de piora ou melhora dos sintomas.

- Antecedentes:
  - Tabagismo; medicamentos em uso para doenças prévias;
  - Exposição a irritantes químicos ou ambientais que afetam a respiração;
  - Doença obstrutiva crônica prévia (asma, enfisema, bronquite);

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Terapia domiciliar de O2;
- Doenças respiratória em tratamento (pneumonia, tuberculose, câncer de pulmão), ou doença cardíaca que possa ter relação com a queixa respiratória como na Insuficiência cardíaca congestiva;
- Dor no tórax ao respirar.

- Inspeção/observação rápida:
  - Presença de cianose central ou de extremidades;
  - Uso de musculatura acessória evidenciado por esforço respiratório intenso com presença de retração intercostal ou retração de fúrcula e supra esternal, batimento de asas de nariz;
  - Presença de sudorese;
  - Enchimento capilar normal quando menor que 2 segundos;
  - Alteração no nível de consciência (agitação psicomotora a sonolência sugestiva de hipóxia).

13.2. Coleta de dados direcionada a pacientes com queixas cardiocirculatórias

- Principais queixas: Dor torácica (dor no peito); dispneia (falta de ar), ortopneia, tosse (que podem estar associadas a doenças cardíacas); fadiga aos pequenos esforços, cianose ou palidez, aumento de pressão arterial (hipertensos ou não), coração acelerado/palpitações, edema.

  A DOR TORÁCICA é um dos sintomas apresentados que causam maior dificuldade no momento da triagem, em definir o encaminhamento imediato ou não para a avaliação médica, visto que pode ser manifestação de várias alterações orgânicas pois que a caixa torácica abriga várias estruturas de órgãos e sistemas como o digestório, cardiovascular, respiratório, osteomuscular e linfático.

- Sinais de alerta: Atenção especial ao padrão e frequência cardíaca, Sat O2, febre, palidez e sudorese.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Queixa atual: Início dos sinais e sintomas apresentados; Fatores de piora ou melhora dos sintomas (dor aos esforços, ao respirar, com tosse).
- Antecedes:
  - História pregressa de cardiopatias (Cirurgia Cardíaca, IAM, Insuficiência Cardíaca, Chagas); pacientes com estes antecedentes devem estar um nível acima do demais;
  - Comorbidades como HAS, DM e obesidade também devem ser valorizadas;
  - Estilo de vida (tabagismo, uso de álcool, drogas, sedentarismo).

A coleta de dados permitirá a abordagem rápida da queixa de dor torácica que tem maior relevância clínica como é o caso da dor de origem cardíaca.

- Início/ forma dos sintomas – de início súbito em forma de aperto, opressão, peso, queimação, pontadas;
- Natureza, local e irradiação – desconforto ou dor profunda localizada em precórdio com ou sem irradiação para o MSE, desconforto ou dor epigástrica, na mandíbula ou pescoço devem ser valorizadas;
- Sintomas associados – diaforese, náuseas, vômitos, palidez, extremidades frias, sudorese.

13.3. Coleta de dados direcionada a pacientes com queixas neurológicas

- Principais queixas:
  - Cefaleias (atenção importante deve ser dada ao nível e tipo de dor, início, história prévia, investigar sinais de meningismo como rigidez de nuca);
  - Distúrbios metabólicos (investigar estados de hipoglicemia e hiperglicemia, convulsão);
  - Confusão/desorientação mental, letargia, agitação.

- Queixa atual:
  - Início dos sinais e sintomas apresentados.
    Atenção aos sinais de:

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Intoxicações e overdoses (quantidade ingestão ou uso, tempo decorrido da intoxicação);
- Acidente Vascular Encefálico (escala de Cincinnati);
- Traumatismos (coleta dados da biomecânica do trauma);
- Desidratação severa (idoso, diarreia e vômitos severos).

- Coleta de dados:
  - Pacientes com alteração do estado mental como confusão/desorientação, letargia, agitação, abuso de álcool, tremores, fraqueza e tontura devem ser submetidos à glicemia capilar;
  - Pacientes com história de traumas que envolvem pancada em região craniana devem ser submetidos à avaliação de nível de consciência – Escala de GLASGOW. (Anexo 3).

  Pacientes com queixas de:
  - Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo – face, braços ou perna;
  - Dificuldade súbita de falar ou compreender;
  - Perda visual súbita em um ou ambos os olhos, tontura, perda de equilíbrio, coordenação;
  - Dor de cabeça súbita intensa sem causa aparente;
  - Desvio de Rima;

  Devem ser submetidos a Escala de Cincinnati (Anexo 9).

13.4. Coleta de dados direcionada a problemas na integridade tecidual e sistema tegumentar

- Principais queixas:

  Ferimentos corte-contusos por diversos mecanismos de trauma; ferimentos ocasionados pelo mecanismo de arma branca e /ou arma de fogo; picada de inseto com reação alérgica; reação alérgica aguda ou crônica, acidente com animais peçonhentos (cobra, escorpião); queimadura.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Atenção:

- Atenção a tempo da ocorrência e início dos sintomas, queixas respiratórias;
- Sangramentos e hemorragias sanguíneas;
- Acidentes com animais peçonhentos, picadas de insetos e alergias agudas;
- Alterações sistêmicas ocasionadas por queimaduras.

13.5. Coleta de dados a queixas direcionadas ao sistema gastrintestinal e urinário

- Principais queixas:
  Dor abdominal; dor lombar; epigástrica e fossa ilíaca, supra púbica (baixo-ventre); queixas urinárias; diarreia; constipação intestinal; vômitos.

- Queixa atual:
  Início dos sintomas, localização, irradiação, característica da dor, palidez ou coloração cutânea.

  Atenção:
  Temperatura, escala de dor, face de dor, posição antálgica.

- Antecedentes:
  Comorbidades; tratamentos anteriores, atraso menstrual e sangramento.

  Avaliação da dor dor (5º sinal vital): É uma experiência complexa e subjetiva e tem seu início no sistema nervoso central. Experiência sensorial e emocional associada a um dano tecidual e deve ser considerada.

  Diarreia e vômitos (queixa atual): Atenção quanto ao início, frequência, características: odor, cor, cheiro, presença de sangue, consistência, história alimentar.

  Atenção:
  PA, temperatura; boca seca, lábios ressecados, letargia, confusão mental, diminuição da urina.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

14. REFERÊNCIAS

ABBÊS C, MASSARO A. **Acolhimento com classificação de risco**. Campinas, *Hospital Municipal Mário Gatti*, 2004.

BELO HORIZONTE, Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo técnico para classificação de risco nas UPA´s**. Belo Horizonte: *Secretaria Municipal de Saúde*, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS**. – Brasília: *Ministério da Saúde*, 2009. 56 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002**. Brasília, 2002. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacaosanitaria/estabeleciment os-de-saude/urgencia-e-emergencia/portaria_2048_B.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. **LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 13/12/2018

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. **Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS)** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada**.** – Brasília: *Editora do Ministério da Saúde*, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. **HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde**/ Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: *Ministério da Saúde*, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS**. **Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / Ministério da Saúde**, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília: *Ministério da Saúde*, 2009. 56 p. : il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Acolhimento à demanda espontânea: queixa mais comuns na Atenção Básica**. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: *Ministério da Saúde*, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS**. – Brasília: *Ministério da Saúde*, 2009. 56 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: *Ministério da Saúde*, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. **Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS**) / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília: *Editora do Ministério da Saúde*, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002**. Brasília,2002. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacaosanitaria/estabelecimentos-de-saude/urgencia-e-emergencia/portaria_2048_B.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada.**Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras**/ *Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada*. – Brasília Editora do Ministério da Saúde, 2012.20 p. : il.

Bullard MJ, Unger B, Spence J, Grafstein E, CTAS National Working Group. **Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity**. *CJEM*. 2008;10(2):136-42.

Conselho Federal de Enfermagem. COFEN. **Resolução COFEN 423/2012 Normatiza, no Âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a Participação do Enfermeiro na Atividade de Classificação de Riscos**. Disponível em: http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4232012_8956.html. DOU Nº 70, quarta feira, 11 de abril de 2012.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS. **Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco**. Belo Horizonte, 2006.

MAFRA, AA. et al. **Acolhimento com Classificação de Risco**. Belo Horizonte: *Hospital Odilon Behrens*. 2006. 24p.

MAGALHÃES JÚNIOR HM. **Encaminhamentos responsáveis em um sistema inteligente de atenção regulada da urgência e emergência**. In: MELO MCB, VASCONCELLOS MC (Orgs.) Manual de atenção às urgências e emergências em pediatria. Belo Horizonte: *Escola de Saúde Pública de Minas Gerais*, 2005. Cap.30, p.375-85.

Novaes, Gaby Pedrosa Machado, Nascimento, Priscilla Alves e Amaral, Silvia Helena Rocha. **Protocolos de Classificação de Risco Utilizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) 24 Horas: Uma Questão de Humanização**. *Caderno Saúde e Desenvolvimento*| vol.9 n.5 | julho/dez – 2016.

O´Dwyer G, Matta IEA, Pepe VLE. **Avaliação dos serviços hospitalares de emergência do estado do Rio de Janeiro**. *Ciência Saúde Coletiva*. 2008;13(5):1637-48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. *Secretaria municipal de Saúde*. 2009. Disponível em: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=saude>. Acesso em 18 de ago de 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al. 7ª **Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial**. *Arquivo Brasileiro de Cardiologia*, 107 (3 supl, 3): 1- 83[disponível somente eletronicamente], 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al. III **Diretriz da Sociedade Brasileiras de Cardiologia, sobre Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos**. *Arquivo Brasileiro de Cardiologia*. v. 106, n. 4, supl. 1 São Paulo Abr, 2016.

SÃO LUIZ. **Protocolo de acolhimento com Classificação de Risco Sistema Único de Saúde (SUS)**. *Hospitais Municipais/ São Luiz/ MA, SD*. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_acolhimento_classificacao_risco.pdf. Acesso em 18 jan. 2018.

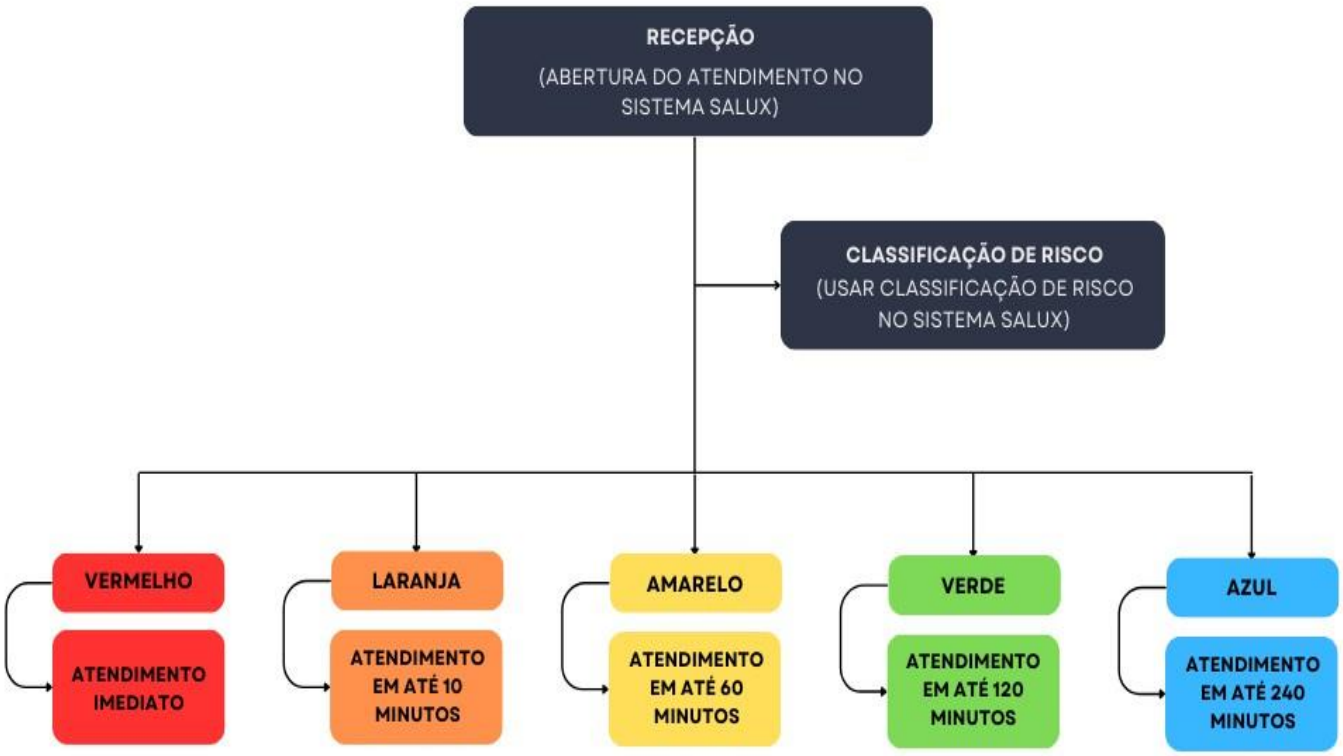
The Canadian Emergency Department Triage & Acuity Scale (CTAS), **Projeto de Acolhimento com Classificação de Risco da Política Nacional de Humanização/ MS, Protocolo de Classificação de Classificação de Risco do Hospital Odilon Beherens, Belo Horizonte/ MG, Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco de Fortaleza/CE**.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

15. ANEXOS

Anexo I – Fluxograma da Classificação de Risco para o setor de Urgência e Emergência da FCECON/AM, 2025.



Fonte: Pronto Socorro FCECON/AM, 2025

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo II – Escala de Coma de Glasgow

Escala de Coma de Glasgow		
Parâmetro	**Resposta obtida**	**Pontuação**
Abertura ocular	Espontânea	4
	Ao estímulo sonoro	3
	Ao estímulo de pressão	2
	Nenhuma	1
Resposta verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Verbaliza palavras soltas	3
	Verbaliza sons	2
	Nenhuma	1
Resposta motora	Obedece comandos	6
	Localiza estímulo	5
	Flexão normal	4
	Flexão anormal	3
	Extensão anormal	2
	Nenhuma	1
Trauma leve	**Trauma moderado**	**Trauma grave**
13-15	9-12	3-8
Reatividade pupilar		
Inexistente	**Unilateral**	**Bilateral**
-2	-1	0

Fonte: Internet, 2025.

*Como classificar o paciente na Escala de Coma de Glasgow com resposta pupilar (ECG-P)?

Primeiro faz-se a avaliação da escala normalmente, levando em conta a resposta de abertura ocular, de fala e de movimentação, somando pontos de acordo com a resposta. Após isso, faz-se a avaliação da reatividade pupilar com estímulo luminoso: se ambas as pupilas estiverem fotorreagentes, não se altera o somatório da escala já feito pelos passos acima; se somente uma das pupilas não estiver reagente, subtrai-se 1 ponto da escala; e se nenhuma das 2 pupilas estiverem reagentes, subtrai-se 2 pontos da escala. Assim, a não reação da pupila indica uma maior gravidade e pior prognóstico.

Esquematizando: ECG-P = ECG – (no de pupilas não reagentes)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo III – Mecanismo do trauma

MECANISMO DE TRAUMA DE ALTO RISCO	Acidente automobilístico com ejeção do veiculo
	Acidente automobilístico com capotamento
	Acidente automobilístico com tempo de restante > 20 minutos.
	Acidente automobilístico com intrusão significante do compartimento do motorista/passageiro
	Acidente automobilístico com óbito no mesmo compartimento do motorista/passageiro
	Acidente automobilístico com impacto frontal em velocidade > 40Km/h (sem cinto de segurança) ou em velocidade > 60Km/h (com cinto de segurança)
	Acidente com motocicleta com impacto de carro em velocidade maior que 30 Km/h, especialmente quando o motociclista é separado da motocicleta
	Atropelamento de pedestre ou ciclista por carro em velocidade > 10 Km/h
	Queda de altura de > 3 vezes a altura do paciente
	Explosão

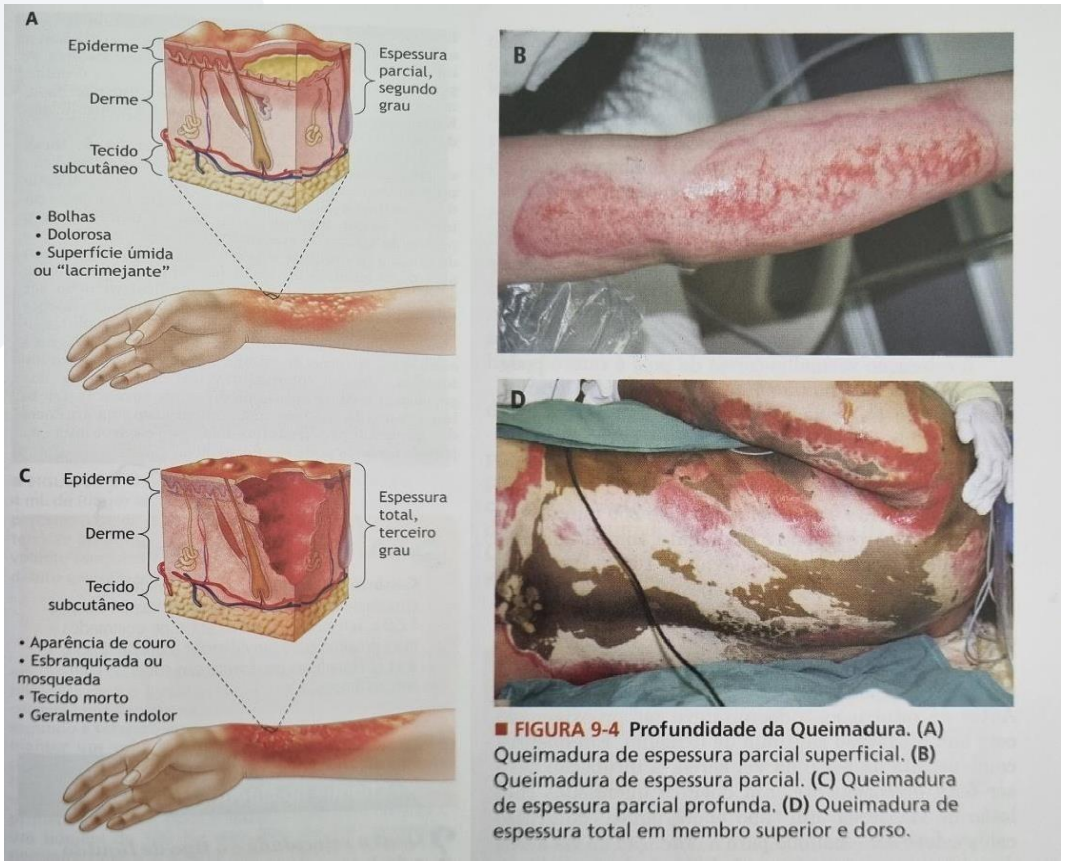
Fonte: Fonte: Acolhimento com classificação de risco, SUS-BH, 2004

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo IV – Classificação das Queimaduras segundo a profundidade do tecido acometido

Classificação das Queimaduras	**1° GRAU –** Caracterizada por eritema, dor e ausência de bolhas (não são contabilizadas para estimar a SCQ)
	2° GRAU – Pele vermelha rota, presença de bolhas, perda da solução de continuidade da pele, edema, extremamente dolorosas.
	3° GRAU – Pele pálida, esbranquiçada, às vezes com transparência dos vasos (coagulados), perda da solução de continuidade da pele com exposição do tecido celular subcutâneo, ausência de dor.

Fonte: Acolhimento com classificação de risco, SUS-BH, 2004



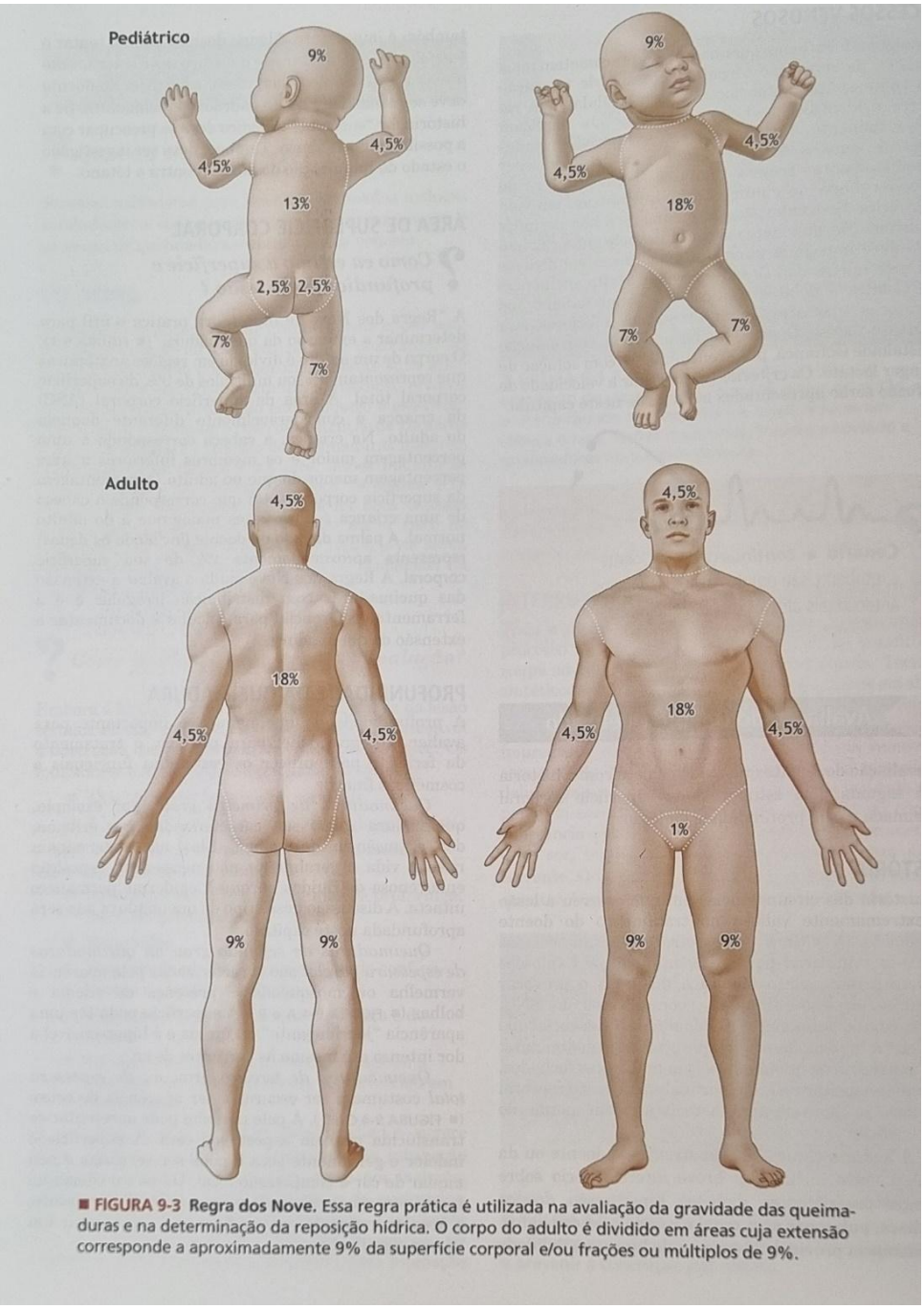
■ FIGURA 9-4 **Profundidade da Queimadura.** (A) Queimadura de espessura parcial superficial. (B) Queimadura de espessura parcial. (C) Queimadura de espessura parcial profunda. (D) Queimadura de espessura total em membro superior e dorso.

Fonte: ATLS 9ª Edição.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo V – Classificação das queimaduras pela extensão (REGRA DOS 9)



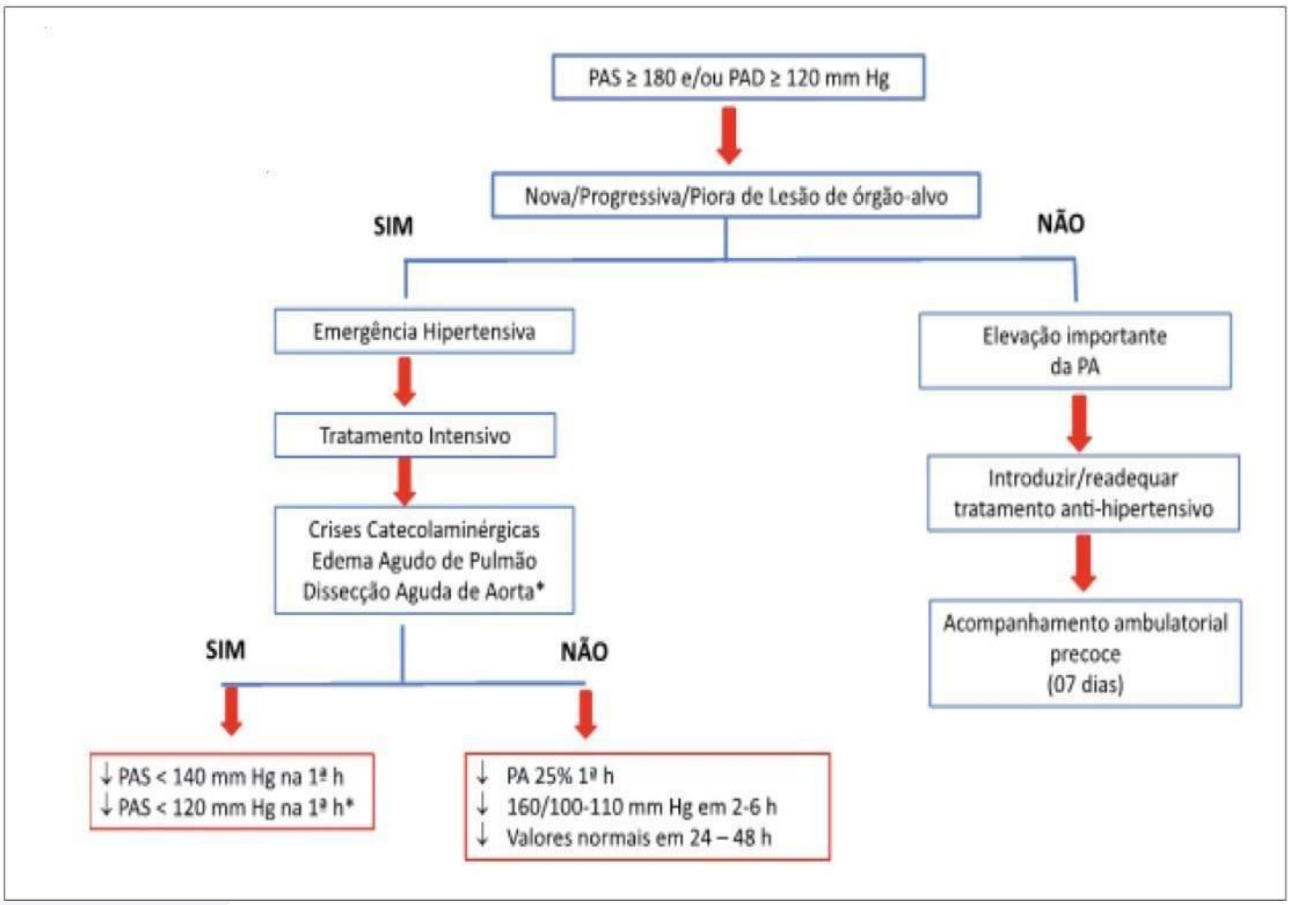
■ FIGURA 9-3 **Regra dos Nove.** Essa regra prática é utilizada na avaliação da gravidade das queimaduras e na determinação da reposição hídrica. O corpo do adulto é dividido em áreas cuja extensão corresponde a aproximadamente 9% da superfície corporal e/ou frações ou múltiplos de 9%.

Fonte: ATLS 9ª Edição.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

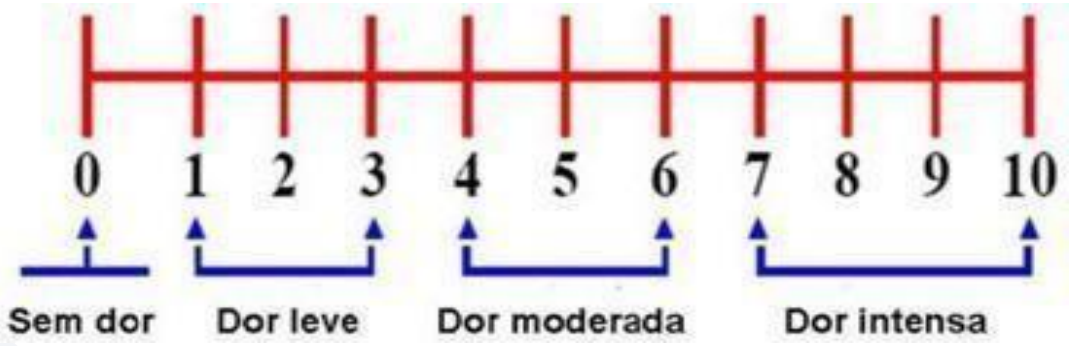
Anexo VI – Alteração da Pressão Arterial



Fonte: Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020.

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo VII – Escala de intensidade da dor



ESCALA VERBAL NUMÉRICA: O paciente deve ser informado sobre a necessidade de classificar sua dor em notas que variam de 0 a 10, de acordo com a intensidade da sensação. Nota zero corresponderia à ausência de dor, enquanto nota 10 a maior intensidade imaginável.



Fonte: Acolhimento com classificação de risco / SUS-BH,2004

Dor leve = 1 a 3 / 10

Dor moderada = 4 a 7 / 10

Dor intensa = 8 a 10 / 10

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/EEC7.BFF0.87BF.C697/AD8288EC
Código verificador: **EEC7.BFF0.87BF.C697** CRC: **AD8288EC**
Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo VIII – Escala de AVC e Cincinnati

Tabela 5. A Escala Pré-Hospitalar de Cincinnati para AVC — LAPPS

Teste	Achados
Paralisia facial: peça ao paciente para mostrar os dentes ou sorrir (Figura 27)	**Normal** — os dois lados do rosto se movem igualmente **Anormal** — um dos lados do rosto não se move tão bem quanto o outro
Queda do braço: o paciente fecha os olhos e estende ambos os braços retos, com as palmas para cima, por 10 segundos (Figura 28)	**Normal** — os dois braços se movem *ou* nenhum dos braços consegue se mover (outros achados, como desvio pronador, podem ajudar) **Anormal** — um dos braços se move *ou* um dos braços apresenta desvio para baixo em comparação com o outro
Fala anormal: Peça ao paciente que diga "não dá para perder os velhos hábitos"	**Normal** — o paciente diz as palavras corretas, sem fala arrastada **Anormal** — o paciente pronuncia as palavras de forma arrastada, diz as palavras erradas ou é incapaz de falar

Interpretação: Se qualquer um desses 3 sinais estiver anormal, a probabilidade de AVC é de 72%. A presença de todos os 3 achados indica que a probabilidade de AVC é superior a 85%.

Modificada de Kothari RU, Pancioli A, Liu T, Brott T, Broderick J. Cincinnati Prehospital Stroke Scale: reproducibility and validity. *Ann Emerg Med.* 1999;33(4):373-378. Com a permissão da Elsevier.

Fonte: American Heart Association - ACLS

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

16. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	16/12/2025	Elaboração do Protocolo

Elaboração: **Comissão de elaboração do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco na Unidade de Pronto Socorro no Serviço de Urgência e Emergência** • Rosangela das Neves Smith – Gerente do Serviço de Urgência e Emergência • Emanuel Pires Corrêa – Médio assistencial do Serviço de Urgência e Emergência • Evelyn Cristina Alves Trindade – Estagiária de Enfermagem do Serviço de Urgência e Emergência	**Data:** 16/12/2025 ROSANGELA DAS NEVES SMITH:42847877215 Assinado de forma digital por ROSANGELA DAS NEVES SMITH:42847877215 Dados: 2025.12.16 16:06:11 -04'00' gov.br Documento assinado digitalmente EMANUEL PIRES CORREA Data: 16/12/2025 08:28:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br Documento assinado digitalmente EVELYN CRISTINA ALVES TRINDADE Data: 17/12/2025 09:05:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação: Gerson Antônio dos Santos Mourão – Diretor Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas	**Data:** 16/12/2025 GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURAO:05429005215 Assinado de forma digital por GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURAO:05429005215

Assinado digitalmente por: LAURA RITA CAVALCANTE DA SILVEIRA em 19/12/2025 às 11:40:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.